

TEMA 9.2 • RESPIRATORIO

Influenza

PERFIL EUNACOM 1.04.1.016

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción y Definiciones

Es fundamental distinguir entre el agente etiológico y la enfermedad clínica. La **COVID-19** es la enfermedad causada por el coronavirus descubierto en el año 2019. El virus propiamente tal se denomina **SARS-CoV-2**.

NOTA CLÍNICA

El nombre **SARS** hace referencia al Síndrome de Dificultad Respiratoria Severa (Severe Acute Respiratory Syndrome), un cuadro de afectación respiratoria habitualmente aguda y grave. El SARS-CoV-2 es evolutivamente distinto al SARS-CoV-1, responsable del brote de SARS en China a principios de los años 2000.

Espectro Clínico

La presentación de la infección por SARS-CoV-2 es sumamente heterogénea, abarcando desde cuadros silentes hasta fallas orgánicas múltiples:

- **Asintomáticos:** Pacientes que portan y transmiten el virus sin desarrollar síntomas.
- **Infección Respiratoria Alta Leve:** Cuadro similar a un resfriado común.
- **Síndrome Gripal:** Caracterizado por fiebre, mialgias, cefalea y compromiso del estado general, muy similar a la **Influenza**.
- **Neumonía Viral / Neumonitis:** Cuadro severo que puede progresar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda (SARS), requiriendo soporte ventilatorio.

Factores de Riesgo para Progresión Grave

La identificación temprana de pacientes con riesgo de evolucionar hacia una **neumonía grave** es crucial en el manejo inicial.

- **Edad:** Es el factor de riesgo más importante; a mayor edad, mayor es la probabilidad de complicaciones y mortalidad.
- **Factores de Riesgo Cardiovascular:**
 - **Hipertensión Arterial** esencial.
 - **Obesidad** (uno de los predictores más fuertes de mala evolución).
 - Antecedentes de patología cardiovascular previa.
 - **Diabetes Mellitus** tipo 2.
- **Patologías Crónicas:** Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas o **Insuficiencia Cardíaca** que presentan una reserva funcional limitada y se descompensan ante la infección viral.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Cualquier paciente con comorbilidades cardiovasculares debe ser monitorizado estrechamente, ya que la COVID-19 no solo afecta el pulmón, sino que genera un estado inflamatorio sistémico que descompensa patologías de base.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en pruebas moleculares, de antígenos e imágenes.

Pruebas de Laboratorio

TABLA 9.2.1: EXAMEN VS SENSIBILIDAD

EXAMEN	SENSIBILIDAD	ESPECIFICIDAD	OBSERVACIONES
PCR (RT-PCR)	~90%	~100%	Gold Standard. Muy sensible y específica.
Test de Antígeno	Menor (Variable)	~100%	Resultado inmediato. Útil principalmente en pacientes con síntomas .

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En pacientes asintomáticos, el test de antígeno tiene baja sensibilidad y un resultado negativo no descarta la infección. Sin embargo, en pacientes sintomáticos, su sensibilidad se acerca a la de la PCR, siendo una herramienta de tamizaje rápido muy eficaz.

Diagnóstico por Imágenes

- **Radiografía de Tórax:** Puede sugerir el cuadro (infiltrados intersticiales o alveolares), pero es inespecífica.
- **TAC de Tórax (Scanner):** Es mucho más sensible. Existen patrones radiológicos (como el vidrio esmerilado periférico y bilateral) que son tan característicos que pueden permitir el diagnóstico categórico de COVID-19 incluso antes de contar con la PCR.

Manejo y Tratamiento

El tratamiento se estratifica según la gravedad del cuadro clínico:

1. Manejo Ambulatorio (Leve)

- **Asintomáticos:** No requieren tratamiento médico, solo aislamiento. - **Sintomáticos leves (Síndrome gripal):** Tratamiento sintomático. El fármaco de elección es el **Paracetamol**.

2. Manejo Hospitalario (Moderado a Grave)

Cuando existe evidencia de neumonía o requerimiento de oxígeno, el manejo se vuelve complejo y de soporte:

- **Corticoides (Dexametasona):** Es uno de los pilares del tratamiento, ya que ha demostrado disminuir significativamente la mortalidad en pacientes que requieren soporte de oxígeno.
- **Heparina de Bajo Peso Molecular (Anticoagulación):** Se utiliza de forma profiláctica (o terapéutica según el caso) para prevenir complicaciones trombóticas asociadas al estado de hipercoagulabilidad de la enfermedad.
- **Soporte Respiratorio:** Desde naricera simple hasta ventilación mecánica invasiva.
- **Antivirales:** Existen fármacos específicos (como el Remdesivir) que se discuten en el contexto de **Neumonía** viral intrahospitalaria.

EUNACOM CRITERIOS

El uso de corticoides está indicado principalmente en pacientes que requieren oxígeno. Su uso en etapas muy precoces o cuadros leves sin hipoxemia podría no ser beneficioso o incluso ser perjudicial.

Prevención

- La estrategia preventiva se divide en dos pilares:
- **Vacunación:** La medida más efectiva para prevenir cuadros graves y muerte.
- **Medidas de Control de Infección:** Uso de mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico y ventilación de espacios, comunes a todas las infecciones respiratorias virales.

Para más detalles sobre complicaciones respiratorias, ver **Neumonía y Insuficiencia Respiratoria**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Paciente de 32 años consulta por fiebre de 39.5°C, mialgias intensas, cefalea y tos seca de 24 horas de evolución. Se confirma influenza A por panel viral. Tiene antecedente de asma bronquial en tratamiento. ¿Cuál es el manejo más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Influenza. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Tríada clásica de influenza: fiebre alta (>38-40°C) + mialgias con compromiso del estado general + tos. La tos diferencia de otras infecciones febriles.
- Rango clínico muy amplio: desde resfrío simple hasta neumonía viral grave. Puede complicarse con sobreinfección bacteriana.
- Diagnóstico históricamente CLÍNICO. En la práctica actual se confirma con panel viral (PCR) solo cuando hay gravedad o se necesita decidir tratamiento adicional.
- Tratamiento de primera línea: PARACETAMOL. AINEs como segunda línea. NUNCA aspirina (riesgo de síndrome de Reye: hepatitis + edema cerebral).
- Oseltamivir según gravedad: GRAVE → endovenoso. LEVE alto riesgo → oral. LEVE bajo riesgo → NO se indica.
- En NIÑOS el oseltamivir NO ha demostrado beneficio, ni siquiera en alto riesgo. Solo se usa en niños GRAVES.
- Oseltamivir también se usa como PROFILAXIS en contactos de alto riesgo. Debe iniciarse dentro de las primeras 48 horas para ser efectivo.
- Grupos de alto riesgo: >65 años, embarazadas, enfermedades crónicas (DM, EPOC, IRC, inmunosupresión, DHC, obesidad IMC>40, ICC), trabajadores de salud.
- Los grupos de riesgo reciben: antivirales (tratamiento y profilaxis) + vacuna gratuita en el plan de vacunación chileno.
- Vacunación gratuita incluye además a niños desde 6 meses hasta 5° básico (aunque no reciben antivirales profilácticos).
- La evidencia de utilidad de antivirales en influenza es MUY escasa, pero la recomendación sigue siendo usarlos en casos seleccionados.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (INFLUENZA)

PREGUNTA 1

Paciente de 32 años consulta por fiebre de 39.5°C, mialgias intensas, cefalea y tos seca de 24 horas de evolución. Se confirma influenza A por panel viral. Tiene antecedente de asma bronquial en tratamiento. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A) Paracetamol y aspirina para el manejo de la fiebre y mialgias
- B) Paracetamol como manejo sintomático exclusivo
- C) Paracetamol más oseltamivir oral
- D) Oseltamivir endovenoso y hospitalización
- E) Amoxicilina por sospecha de sobreinfección bacteriana

PREGUNTA 2

Mujer de 28 años, embarazada de 30 semanas, consulta porque su pareja fue diagnosticado con influenza A confirmada hace 12 horas. Ella está asintomática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Observar y consultar solo si presenta síntomas
- B) Solicitar panel viral y esperar resultado antes de decidir
- C) Iniciar oseltamivir profiláctico
- D) Vacunar contra influenza de inmediato como profilaxis
- E) Indicar zanamivir inhalado por ser más seguro en embarazo

PREGUNTA 3

Niño de 4 años con antecedente de cardiopatía congénita presenta fiebre de 38.8°C, tos y mialgias. Panel viral confirma influenza B. El cuadro es leve. ¿Cuál es el manejo más adecuado?

- A) Paracetamol más oseltamivir oral por ser grupo de alto riesgo
- B) Manejo sintomático con paracetamol exclusivamente
- C) Ibuprofeno más oseltamivir endovenoso
- D) Aspirina infantil para la fiebre y mialgias
- E) Antibióticos empíricos por riesgo de sobreinfección en cardiópata

RESUMEN: INFLUENZA

La influenza es una de las infecciones respiratorias altas más importantes debido a la intensidad de sus síntomas y su potencial de complicarse con neumonía viral o sobreinfección bacteriana. Su clínica clásica es la tríada de fiebre alta (>38-40°C), mialgias con gran compromiso del estado general, y tos. La cefalea es también muy frecuente. Es fundamental recordar que el rango de manifestaciones va desde un simple resfrío hasta una neumonía viral grave. El diagnóstico históricamente es clínico (síndrome gripal), pero en la práctica actual se confirma con panel viral por PCR cuando se plantea un tratamiento adicional o se necesita descartar COVID-19. En pacientes leves sin factores de riesgo, no se requieren exámenes: el manejo es sintomático independientemente del agente causal. El tratamiento de primera línea es paracetamol. Los AINEs se pueden usar como segunda línea, EXCEPTO la aspirina (ácido acetilsalicílico), que está contraindicada por el riesgo de síndrome de Reye (hepatitis + edema cerebral). Los antivirales (oseltamivir, zanamivir, peramivir) se indican según gravedad: en graves por vía endovenosa, en leves de alto riesgo por vía oral, y en bajo riesgo no se indican. En niños, el oseltamivir no ha demostrado beneficio incluso en alto riesgo, solo se usa en graves. El antiviral también se usa como profilaxis en contactos de alto riesgo, idealmente dentro de las primeras 48 horas. Los grupos de alto riesgo son: mayores de 65 años, embarazadas, adultos con enfermedades crónicas (diabetes, EPOC, IRC, inmunosupresión, DHC, obesidad mórbida IMC>40, ICC), y trabajadores de la salud. Estos grupos reciben antivirales y vacuna gratuita. Los niños desde 6 meses hasta 5° básico también reciben vacuna gratuita aunque no reciben antivirales profilácticos.